
Internal AW code space
AMPICILLIN
SULBACTAM BIO
SOONOW
MONOOS
Prescription only Medicine
AMPICILLIN
SULBACTAM BIO
AMPICILLIN AND SULBACTAM
FOR INJECTION USP
1.5 gm
(For I.V/I.M only)
Powder for Injection
1 Vial
Производитель:
SWISS PARENTERALS LTD.
Plot No.: 402, 412-414, Kerala Industrial Estate,
G.I.D.C., Nr. Bavla, Dist.: Ahmedabad-382 220,
Gujarat, INDIA.
Mfg. Lic. No. :
Lic. no. Space
8 904180 256146
MONOOS
Ампициллин
сульбактам Био
АМПИЦИЛЛИН И СУЛЬБАКТАМ
ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ ПО
1,5 г
(Только для вв/вм введения)
Порошок для приготовления
раствора для инъекции
Условия отпуска
По рецепту врача
1 Флакон
Состав:
Каждый флакон содержит:
Ампициллин натрия USP
эквивалентный ампициллину
(безводному) 1.0 г.
Сульбактам натрия USP
эквивалентный Сульбактаму 500 мг.
Дозировка:
По назначению врача.
Условия хранение:
Хранить в сухом, защищенном
от света месте, при температуре
не выше 25°C.
ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ
ДЕТЕЙ МЕСТЕ.
Подробности о восстановлении
и способе применения приведены
в инструкции по медицинскому
применению.
Выбросьте любой
неиспользованный продукт сразу
же после использования.
Восстановленный раствор следует
использовать сразу же после
приготовления.
CMYK
Место для
нанесения/наклеивания
средства цифровой
идентификации
И GTIN
B NO
MFG
EXP
SRNO
Interna code space



CMYK



Enlarge Size

ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ

Ампициллин сульбактам Био

Торговое название препарата: Ампициллин сульбактам Био
Действующее вещество (МНН): ampicillin + sulbactam
Лекарственная форма: порошок для приготовления раствора для инъекции
Состав:
Ампициллина натрия эквивалентный ампициллину – 1000 мг;
Сульбактам натрия эквивалентный сульбактаму – 500 мг.
Описание: белый или кремовый кристаллический порошок без запаха или практически без запаха.
Фармакотерапевтическая группа: Противомикробные препараты системного действия. Антибактериальные препараты системного действия. Бета-лактамные антибактериальные препараты, пенициллины. Ампициллин в комбинации с ингибиторами ферментов.
Код АТХ: J01CR01

Фармакологические свойства
Фармакодинамика
Механизм действия
Ампициллин — полусинтетический аминопенициллин, неустойчивый к действию бета-лактамаз. Сульбактам представляет собой ингибитор бета-лактамаз с химической структурой, сходной с ампициллином и другими пенициллинами.
Фармакологический эффект ампициллина основан на подавлении синтеза клеточной стенки бактерий (на стадии роста) путём блокирования пенициллинсвязывающих белков (ПСБ), таких как транспептидазы, что оказывает бактерицидное действие.
В комбинации с сульбактамом предотвращается инактивирование ампициллина определёнными бета-лактамазами. Сульбактам защищает ампициллин от разрушения большинством бета-лактамаз, продуцируемых стафилококками, а также рядом плазмидных (например, TEM, OXA) и хромосомных бета-лактамаз грамотрицательных бактерий, таких как *Escherichia coli*, *Klebsiella spp.*, *Proteus mirabilis*, *Haemophilus influenzae*.
Таким образом, антибактериальный спектр ампициллина расширяется за счёт действия на микроорганизмы, продуцирующие бета-лактамазы, чувствительные к сульбактаму.
Фармакокинетика
Высокие уровни в сыворотке крови достигаются как при внутривенном, так и при внутримышечном введении ампициллина/сульбактама. Результаты фармакокинетических исследований у добровольцев представлены в таблице ниже, в зависимости от времени, дозы и способа введения:

Способ введения	Доза	15 мин	30 мин	1 ч	2 ч	4 ч	6 ч	8 ч
В/м	0.25 г сульб. + 0.5 г амп.	6	7	6	3	1	0.3	0.1
В/м	0.5 г сульб. + 1 г амп.	9	12	12	6	2	0.4	0.2
В/в	0.5 г сульб. + 1 г амп.	8	11	12	8	3	1	0.4
В/в	0.5 г сульб. + 1 г амп.	10	16	17	13	4	1	0.6
В/в	1 г сульб. + 2 г амп.	51	37	21	9	2	0.7	0.3/0.4

Средние концентрации в сыворотке (мг/л).
Пиковые концентрации в сыворотке при внутривенном введении выше, чем при внутримышечном. Однако биодоступность ампициллина/сульбактама после внутримышечного введения практически полная.
Ампициллин и сульбактам также быстро распределяются в многочисленные ткани, жидкости организма и секреты.
Период полувыведения как сульбактама, так и ампициллина составляет около 1 часа у молодых взрослых и около 2 часов у пожилых пациентов. Около 80% обеих субстанций выводится почками в течение 8 часов после однократного введения ампициллина/сульбактама.
Совместное введение сульбактама и ампициллина не вызывает клинически значимых отклонений фармакокинетических параметров по сравнению с отдельным применением этих веществ.

Показания к применению
Ампициллин/Сульбактам показан для лечения следующих инфекций:
- внебольничная пневмония;
- инфекции верхних мочевыводящих путей;
- интраабдоминальные инфекции;
- гинекологические инфекции;
- инфекции кожи и мягких тканей;
- профилактика инфекций, связанных с абдоминальными хирургическими вмешательствами.

Следует учитывать официальные рекомендации по рациональному применению антибактериальных средств.

Способ применения и дозы
Рекомендуемая доза для взрослых составляет от 3 до 12 г Ампициллина/Сульбактама в сутки, в зависимости от тяжести инфекции, разделённая на равные дозы каждые 6–8 часов.
Дети:
Дети старше 2 лет: Рекомендуемая суточная доза — 150 мг/кг/сут (ампициллин — 100 мг/кг/сут + сульбактам — 50 мг/кг/сут), вводится в 3–4 приёма.
Новорожденные, младенцы и дети до 2 лет: Ампициллин/Сульбактам должен применяться только внутривенно.
От второй недели жизни до 2 лет: доза — 150 мг/кг/сут (ампициллин — 100 мг/кг/сут + сульбактам — 50 мг/кг/сут), вводится в 3–4 приёма.
В первую неделю жизни: доза — 75 мг/кг/сут (ампициллин — 50 мг/кг/сут + сульбактам — 25 мг/кг/сут), вводится в 2 приёма.
Пожилые пациенты:
Ампициллин/Сульбактам может применяться у пожилых пациентов в стандартных дозировках без особых предосторожностей.
Профилактика послеоперационных инфекций:
Вводится от 1,5 до 3 г Ампициллина/Сульбактама во время введения в наркоз, что обеспечивает достижение эффективной концентрации в сыворотке крови и тканях на момент начала хирургического вмешательства.
При продолжительных операциях возможно повторное введение дозы через 3–4 часа.
В большинстве случаев введение Ампициллина/Сульбактама прекращают через 24 часа после завершения операции, если не требуется продолжение терапии.

Применение у пациентов с нарушением функции почек:
У пациентов с тяжёлой почечной недостаточностью (клиренс креатинина < 30 мл/мин) скорость выведения сульбактама и ампициллина снижается одинаково, и их соотношение в плазме остаётся постоянным вне зависимости от степени нарушения функции почек.
Частота введения должна быть уменьшена согласно стандартным рекомендациям для ампициллина:

Клиренс креатинина (мл/мин)	Интервал между введениями
>30	каждые 6–8 часов
15–30	каждые 12 часов
5–14	каждые 24 часа
<5	каждые 48 часов

Ампициллин и сульбактам эффективно удаляются из крови при гемодиализе. Поэтому пациентам, находящимся на гемодиализе, следует вводить препарат немедленно после процедуры, а затем каждые 48 часов до следующего сеанса.
Применение у пациентов с нарушением функции печени:
Применяют в стандартных рекомендованных дозах.
Продолжительность лечения:
Продолжительность лечения зависит от течения заболевания и обычно составляет от 5 до 14 дней. В тяжёлых случаях возможно более длительное применение. Рекомендуется продолжать терапию ещё 48 часов после нормализации температуры тела и исчезновения симптомов заболевания.

Побочные действия
Со стороны пищеварительной системы: тошнота, рвота, снижение аппетита, диарея, повышение активности «печеночных» трансаминаз; редко - псевдомембранозный энтероколит.
Со стороны органов кроветворения и системы гемостаза: анемия, лейкопения, тромбоцитопения.
Со стороны нервной системы: сонливость, недомогание, головная боль.
Лабораторные показатели: азотемия, повышение концентрации мочевины, гиперкреатининемия.
Аллергические реакции: крапивница, гиперемия кожи, ангионевротический отек, ринит, конъюнктивит, лихорадка, артралгия, эозинофилия, в редких случаях - анафилактический шок.
Местные реакции: при в/м введении - болезненность в месте введения; при в/в - флебит.
Прочие: при длительном лечении - суперинфекция, вызванная устойчивыми к препарату микроорганизмами (кандидоз).

Противопоказания
Повышенная чувствительность к любому из компонентов препарата и другим бета-лактамным антибиотикам; инфекционный мононуклеоз (в т.ч. при появлении кореподобной сыпи), лимфолейкоз.
Безопасность применения ампициллина+сульбактам у пациентов с терминальной стадией хронической почечной недостаточности (клиренс креатинина менее 5 мл/мин) не установлена.
При использовании прокаина, лидокаина в качестве растворителя - повышенная чувствительность к местным анестетикам амидного типа, тяжелый шок, блокада внутрисердечного проводимости, тяжелая сердечная недостаточность.
С осторожностью:
Бронхиальная астма, поллиноз и другие аллергические заболевания, печеночная недостаточность, хронические заболевания желудочно-кишечного тракта в анамнезе, ранее перенесенный колит, связанный с применением антибактериальных препаратов, нарушения функции почек, пожилой возраст.
Применение в детском возрасте: применение возможно согласно режиму дозирования.

Лекарственные взаимодействия
Применение ампициллина может снижать эффективность пероральных гормональных контрацептивов. В связи с этим во время лечения рекомендуется использовать дополнительные негормональные методы контрацепции.
Сообщалось о случаях развития антибиотик-ассоциированной колита при применении практически всех антибактериальных препаратов, включая ампициллин/сульбактам. Тяжесть колита может варьировать от лёгкой до угрожающей жизни. (Поэтому у пациентов, у которых развивается диарея во время лечения или после него, следует учитывать возможность развития данного осложнения.
При подозрении на антибиотик-ассоциированный колит приём препарата Ампициллин/Сульбактам должен быть немедленно прекращён, пациенту следует обратиться к врачу, и должно быть начато соответствующее лечение. Применение противодиарейных препаратов, замедляющих перистальтику, в данной ситуации противопоказано.
Влияние других лекарственных средств:
Ацетилсалициловая кислота, индометацин и фенилбутазон снижают выведение пенициллинов.
Другие антибиотики и химиотерапевтические средства: Препарат Ампициллин/Сульбактам не рекомендуется применять совместно с бактериостатическими химиотерапевтическими средствами или антибиотиками, такими как тетрациклины, эритромицин, сульфаниламиды или хлорамфеникол, из-за возможности снижения эффективности терапии.
Аминогликозиды:
Аминогликозиды инактивируются ампициллином *in vitro*, поэтому их нельзя смешивать с ампициллином/сульбактамом в одном растворе для инфузий. При необходимости совместного применения препараты следует вводить в разные участки тела с интервалом не менее одного часа.
Аллопуринол:
У пациентов с подагрой, получающих лечение аллопуринолом, одновременное применение ампициллина/сульбактама повышает риск развития кожных реакций.
Антикоагулянты:
Изменения агрегации тромбоцитов и протромбинового времени, наблюдаемые при парентеральном введении пенициллинов, могут усиливаться при одновременном применении антикоагулянтов.
Метотрексат:
Одновременное применение метотрексата и пенициллинов приводит к снижению клиренса метотрексата и, как следствие, к его токсичности. Таким пациентам необходим тщательный мониторинг, следует рассмотреть возможность увеличения дозы и продолжительности применения фолиновой кислоты (лейковорина).
Пробенецид:
Совместное применение с пробенецидом приводит к повышению и более длительному сохранению концентраций ампициллина и сульбактама в сыворотке крови, а также ампициллина в желчи, за счёт угнетения почечной экскреции (тубулярной секреции).
Гормональные контрацептивы:
Во время лечения аминопенициллинами в редких случаях возможно снижение надёжности действия гормональных контрацептивов (например, «противозачаточных таблеток»). В связи с этим рекомендуется дополнительное применение негормональных методов контрацепции.
Влияние на лабораторные тесты:
Высокая концентрация ампициллина в моче может вызывать ложноположительные результаты при определении глюкозурии. Рекомендуется использовать тесты на глюкозу, основанные на ферментативной реакции с глюкозооксидазой.

Особые указания
Перед началом терапии ампициллином/сульбактамом необходимо тщательно собрать анамнез относительно ранее перенесённых реакций гиперчувствительности на пенициллины, цефалоспорины или другие бета-лактамные препараты.
Сообщалось о развитии тяжёлых и в отдельных случаях летальных реакций гиперчувствительности (анафилактоидного типа) у пациентов, получающих терапию пенициллинами. Такие реакции чаще возникают у пациентов с предшествующей гиперчувствительностью к пенициллинам, цефалоспоринам, а также у атопиков.
При возникновении аллергической реакции применение ампициллина/сульбактама необходимо немедленно прекратить и назначить соответствующее альтернативное лечение.
Тяжёлые анафилактические реакции требуют неотложного лечения адреналином. При необходимости также вводят кислород, глюкокортикостероиды внутривенно и проводят мероприятия по обеспечению проходимости дыхательных путей, включая интубацию.
До начала лечения пенициллинами следует тщательно выяснить наличие ранее отмечавшихся реакций гиперчувствительности на пенициллины, цефалоспорины и другие препараты.
Препарат следует избегать применять при подозрении на инфекционный мононуклеоз, поскольку на фоне применения амоксициллина в таких случаях часто развивается морбиллоподобная сыпь.
При длительном применении (более 14 дней) рекомендуется периодическая оценка функции жизненно важных органов, включая функции почек, печени и системы кроветворения. Особенно важно проводить мониторинг у новорождённых и других педиатрических пациентов.
Как и при любой антибактериальной терапии, врач должен быть внимателен к признакам избыточного роста нечувствительных микроорганизмов (включая грибы). При развитии суперинфекции препарат следует отменить и при необходимости назначить соответствующее лечение.
Продолжительное применение может привести к избыточному росту микроорганизмов, нечувствительных к препарату.
Во время лечения препаратом Ампициллин/Сульбактам для определения глюкозы в моче следует использовать только ферментные методы с глюкозооксидазой, поскольку при использовании неферментных методов возможны ложноположительные результаты.
Применение при нарушениях функции печени
С *осторожностью*: печеночная недостаточность.
Применение при нарушениях функции почек
С *осторожностью*: почечная недостаточность.
Применение у детей
Применение возможно согласно режиму дозирования.
Применение при беременности и период лактации
Фертильность:
В доклинических исследованиях у животных ампициллин и сульбактам не оказывали неблагоприятного влияния на фертильность.
Беременность:
Имеются ограниченные данные о применении ампициллина и сульбактама у беременных женщин. Полученные сведения не свидетельствуют о вредном влиянии на течение беременности или на здоровье плода/новорождённого. Однако данных о применении в первом триместре недостаточно.
В исследованиях на животных признаков тератогенного действия выявлено не было.
Препарат Ампициллин/Сульбактам следует применять при беременности только в случае, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода.
Период грудного вскармливания:
Ампициллин и сульбактам выделяются с грудным молоком. Несмотря на низкий уровень экскреции, у грудных детей возможно развитие диареи, кандидоза слизистых оболочек, а также развитие аллергической сенсибилизации.
При необходимости назначения препарата в период грудного вскармливания следует решить вопрос о прекращении кормления грудью или отмене/приостановке терапии с учётом пользы для ребёнка и матери.
Влияние на способность управлять автомобилем и сложными механизмами
Специальных исследований по изучению влияния ампициллина и сульбактама на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами не проводилось. Однако пациентам следует сообщить, что на фоне применения препарата возможны нежелательные реакции, которые могут снижать скорость реакции и способность к концентрации внимания.

Передозировка
Опыт наблюдений за острым токсическим действием ампициллина/сульбактама ограничен.
Передозировка может вызывать симптомы, соответствующие профилю нежелательных реакций, при этом указанные побочные эффекты могут наблюдаться чаще и проявляться в более выраженной форме.
При применении β-лактамных антибиотиков в очень высоких дозах возможно развитие судорожного синдрома (эпилептических припадков).
Поскольку ампициллин и сульбактам выводятся из организма с помощью гемодиализа, при передозировке, особенно у пациентов с почечной недостаточностью, эффективность элиминации может быть повышена за счёт проведения гемодиализа.
Лечение:
При судорогах, вызванных передозировкой, возможно применение седативной терапии с использованием диазепама.

Форма выпуска
Флакон из стекла объемом 10 мл, упакованный в картонную коробку вместе с инструкцией по медицинскому применению.
1 флакон с препаратом вместе с инструкцией по применению вложенный в картонную упаковку.

Условия хранения
Хранить при температуре не выше 25°С.
Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности
3 года.
Не следует применять после истечения срока годности.

Условия отпуска из аптек
По рецепту.

Производитель
«SWISS PARENTERALS LTD», Индия.
Plot No. 402, 412-414, Kerala Industrial Estate,
G.I.D.C, Nr. Bavla, Dist.:Ahmedabad-382 220 Gujarat, Индия.
Веб сайт: http://swiss.in
E-mail: export@swiss.in

Наименование и адрес организации, принимающей претензии (предложения) по качеству лекарственных средств на территории Республики Узбекистан
«ООО VENIT PHARM»
Республика Узбекистан, г. Ташкент Учтепинский район, 24-4-38;
Тел.: + 998907440043

Internal Artwork code Space

ТИББИЁТДА ҚЎЛЛАНИЛИШИГА ДОИР ЙЎРИҚНОМА

Ампициллин сульбактам Био

Препаратнинг савдо номи: Ампициллин сульбактам Био
Таъсир этувчи моддалар (ХПН): ampicillin + sulbactam
Дори шакли: инъекция учун эритма тайёрлаш учун кукун
Таркиби:
Ампициллинга эквивалент ампициллин натрий - 1000 мг;
Сульбактамга эквивалент сульбактам натрий - 500 мг.
Таърифи: ок ёки тўқ сариқ рангли ҳидсиз ёки деярли ҳидсиз кристалл кукун.
Фармакотерапевтик гуруҳи: Тизимли таъсирга эга микробларга қарши препаратлар.Тизимли таъсирга ега антибактериал препаратлар. Бета-лактам антибактериал препаратлар,пенициллинлар. Ампициллин фермент ингибиторлари билан мажмуада.
АТХ коди: J01CR01

Фармакологик хусусиятлари
Фармакодинамикаси
Таъсир механизми
Ампициллин - ярим синтетик аминопенициллин бўлиб, бета-лактамазалар таъсирига чидамли эмас. Сульбактам бета-лактамаза ингибитори бўлиб, кимёвий тузилиши жиҳатидан ампициллин ва бошқа пенициллинларга ўхшайди.
Ампициллиннинг фармакологик таъсири транспептидазалар каби пенициллин боғловчи оқсилларни (ПБО) блоклаш орқали бактериялар ҳужайра девори синтезини (ўсиш боскичида) бостиришга асосланган бўлиб, бактерицид таъсир кўрсатади.
Сульбактам билан мажмуада ампициллиннинг баъзи бета-лактамазалар томонидан фаолсизлантирилишини олдини олади. Сульбактам ампициллинни стафилококклар ишлаб чиқарадиган кўпчилик бета-лактамазалар, шунингдек, *Escherichia coli, Klebsiella spp., Proteus mirabilis, Haemophilus influenzae* каби грамманфий бактерияларнинг бир қатор плазмид (масалан, ТЕМ, ОХА) ва хромосома бета-лактамазалари томонидан парчаланишдан ҳимоя қилади.
Шундай қилиб, ампициллиннинг антибактериал спектри сульбактамга сезгир бета-лактамазаларни ишлаб чиқарадиган микроорганизмларга таъсири туфайли кенгаяди.
Фармакокинетикаси
Ампициллин/сульбактам вена ичига юборилганда ҳам, мушак ичига юборилганда ҳам қон зардобидаги юкори даражага эришилади. Кўнгиллиларда ўтказилган фармакокинетик тадкиқотлар натижалари вакт, доза ва юбориш усулига қараб қуйидаги жадвалда келтирилган:

Юбориш усули	Доза	15 минут	30 минут	1 соат	2 соат	4 соат	6 соат	8 соат
М/и	0.25 г сульб. + 0.5 г амп.	6	7	6	3	1	0.3	0.1
М/и	0.5 г сульб. + 1 г амп.	9	12	12	6	2	0.4	0.2
В/и	0.5 г сульб. + 1 г амп.	8	11	12	8	3	1	0.4
В/и	0.5 г сульб. + 1 г амп.	10	16	17	13	4	1	0.6
В/и	1 г сульб. + 2 г амп.	51	37	21	9	2	0.7	0.3/0.4

Зардобдаги ўртача концентрациялари (мг/л).
Вена ичига юборилганда қон зардобидаги энг юкори концентрациялар мушак ичига юборилганга караганда юкори бўлади. Бироқ, ампициллин/сульбактамнинг мушак ичига юборилгандан кейинги биокираолиши деярли тўлик.
Ампициллин ва сульбактам ҳам кўплаб тўқималар, организм суюкликлари ва секрецияларига тез таркалади.
Сульбактам ва ампициллиннинг ярим чиқарилиш даври ёшларда таҳминан 1 соат, кекса ёшдаги пациентларда эса 2 соат атрофида бўлади. Ампициллин/сульбактам бир марта юборилгандан сўнг 8 соат ичида иккала модданинг тахминан 80% буйраклар орқали чиқарилади.
Сульбактам ва ампициллинни биргаликда қўллаш ушбу моддаларни алоҳида қўллаш билан солиштирганда фармакокинетик параметрларнинг клиник жиҳатдан сезиларли ўзгаришларини келтириб чиқармайди.

Қўлланилиши
Ампициллин/Сульбактам қуйидаги инфекцияларни даволаш учун кўрсатилган:
- касалхонадан ташқари пневмония;
- юкори сийдик-чикариш йўллари инфекциялари;
- интраабдоминал инфекциялар;
- гинекологик инфекциялар;
- тери ва юмшоқ тўқималар инфекциялари;
- абдоминал жарроҳлик аралашувлари билан боғлиқ инфекцияларнинг олдини олиш.

Антибактериал воситаларни оқилона қўллаш бўйича расмий тавсияларни ҳисобга олиш керак.

Қўллаш усули ва дозалари
Катталар учун тавсия этилган доза инфекциянинг оғирлигига қараб кунига 3 дан 12 г гача Ампициллин/Сульбактам бўлиб, ҳар 6-8 соатда тенг дозаларга бўлинади.
Болалар:
2 ёшдан катта болалар: Тавсия этилган суткалик доза - 150 мг/кг/сут (ампициллин - 100 мг/кг/сут + сульбактам - 50 мг/кг/сут), 3-4 кабулда юборилади.
Янги туғилган чақалоқлар, тўдаклар ва 2 ёшгача бўлган болалар: Ампициллин/Сульбактам фақат вена ичига юборилиши керак.
Ҳаётининг иккинчи ҳафтасидан - 2 ёшгача: дозаси - 150 мг/кг/сут (ампициллин - 100 мг/кг/сут + сульбактам - 50 мг/кг/сут), 3-4 кабулда юборилади.
Ҳаётининг биринчи ҳафтасида: дозаси - 75 мг/кг/сут (ампициллин - 50 мг/кг/сут + сульбактам - 25 мг/кг/сут), 2 марта қабулда юборилади.
Кекса ёшли пациентлар:
Ампициллин/Сульбактам кекса ёшдаги пациентларда стандарт дозаларда алоҳида эҳтиёт чоралари кўрилмасдан қўлланилиши мумкин.
Жарроҳликдан кейинги инфекцияларнинг олдини олиш:
Ампициллин/сульбактамни наркозга юбориш вақтида 1,5 дан 3 г гача юборилади, бу жарроҳлик аралашуви бошланишида қон зардоби ва тўқималарда самарали концентрацияга эришишни таъминлайди.
Узоқ давом этадиган жарроҳлик амалиётида 3-4 соатдан кейин дозани кайта юбориш мумкин.
Кўп ҳолларда, агар терапияни давом эттириш талаб қилинмаса, Ампициллин/Сульбактамни юбориш жарроҳлик тугаганидан 24 соат ўтгач тўхтатилади.
Буйрак функцияси бузилиши бўлган пациентларда қўлланилиши:
Огир буйрак етишмовчилиги бўлган пациентларда (креатинин клиренси < 30 мл/минут) сульбактам ва ампициллиннинг чиқарилиш тезлиги бир хил даражада пасаяди ва уларнинг плазмадаги нисбати буйрак функциясининг бузилиш даражасидан қатъий назар доимий бўлиб колади.
Ампициллин учун стандарт тавсияларга мувофик юбориш учраш тез-тезлиги камайтирилиши керак:

Креатинин клиренси (мл/минут)	Юборишлар орасидаги оралиқ
>30	ҳар 6-8 соатда
15–30	ҳар 12 соатда
5–14	ҳар 24 соатда
<5	ҳар 48 соатда

Ампициллин ва сульбактам гемодиализда қондан яхши чиқиб кетади. Шунинг учун гемодиализда бўлган пациентларга муолажадан сўнг дархол, кейин эса ҳар 48 соатда кейинги сеансгача препарат юборилиши керак.
Жигар функцияси бузилиши бўлган пациентларда қўлланилиши:
Стандарт тавсия этилган дозаларда қўлланилади.
Даволаш давомийлиги:
Даволаш муддати касалликнинг кечишига боғлиқ бўлиб, 5 кундан 14 кунгача давом этади. Оғир ҳолатларда узоқроқ қўллаш мумкин. Тана ҳарорати меъёрлашгандан ва касаллик белгилари йўқолгандан сўнг давони яна 48 соат давом эттириш тавсия этилади.

Ножўя таъсирлар
Овқат-ҳазм қилиш тизими томонидан: кўнгил айниши, қусиш, иштаҳанинг пасайиши, диарея, «жигар» трансаминазалари фаоллигининг ошиши; кам ҳолларда - сохтамембраноз энтероколит.
Қон яратиш аъзолари ва гемостаз тизими томонидан: анемия, лейкопения, тромбоцитопения.
Нерв тизими томонидан: уйқучанлик, ҳолсизлик, бош оғриги.
Лаборатор кўрсаткичлар: азотемия, мочевина концентрациясининг ошиши, гиперкреатининемия.
Аллергик реакциялар: эшакеми, тери гиперемияси, ангионевротик шиш, ринит, конъюнктивит, иситма, артралгия, эозинофилия, кам ҳолларда - анафилактик шок.
Маҳаллий реакциялар: м/и юборилганда - юборилган жойда оғрик; в/и юборилганда - флебит.
Бошқалар: узоқ вакт даволанганда - препаратга чидамли микроорганизмлар келтириб чиқарадиган суперинфекция (кандидоз).

Қўллаш мумкин бўлмаган ҳолатлар
Препаратнинг ҳар қандай таркибий қисмига ва бошқа бета-лактам антибиотикларига юкори сезувчанлик; инфекцион мононуклеоз (шу жумладан қизамиққа ўхшаш тошма пайдо бўлганда), лимфолейкоз.
Сурункали буйрак етишмовчилигининг терминал боскичи (креатинин клиренси 5 мл/минутдан кам) бўлган пациентларда ампициллин+сульбактамни қўллаш хавфсизлиги аниқланмаган.
Эритувчи сифатида прокаин, лидокаин ишлатилганда - амид типидаги маҳаллий анестетикларга юкори сезувчанлик, оғир шок, юрак ичи ўтказувчанлигининг блокадаси, оғир юрак етишмовчилигида қўллаш мумкин эмас.
Эҳтиёткоролик билан:
Бронхиал астма, поллиноз ва бошка аллергик касалликлар, жигар етишмовчилиги, анамнезда меъда-ичак йўлларининг сурункали касалликлари, илгари антибактериал препаратларни қўллаш билан боғлиқ колитни бошдан кечирганлик, буйрак функциясининг бузилиши, кексалик.
Болалик даврида қўлланилиши: дозалаш тартибига мувофик қўлланилиши мумкин.

Дориларнинг ўзаро таъсири
Ампициллинни қўллаш перорал гормонал контрацептивларнинг самарадорлигини пасайтириши мумкин. Шу муносабат билан даволаш вақтида қўшимча ногормонал контрацепция усулларидан фойдаланиш тавсия этилади.
Деярли барча антибактериал препаратлар, шу жумладан ампициллин/сульбактам қўлланилганда антибиотик билан боғлиқ колит ривожланиши ҳолатлари кайд этилган. Колитнинг оғирлиги енгил даражадан хаёт учун хавфли даражагача бўлиши мумкин. (Шу сабабли, даволаниш вақтида ёки ундан кейин диарея ривожланган пациентларда ушбу асоратнинг ривожланиш эҳтимолини ҳисобга олиш керак.
Антибиотикка ўхшаш колитга шубҳа туғилганда, Ампициллин/Сульбактам препаратини қабул килиш дархол тўхтатилиши, пациент шифокорга мурожаат килиши ва тегишли даволаниш бошланиши керак. Ушбу вазиятда перистальтикани секинлаштирадиган диареяга қарши препаратларни қўллаш мумкин эмас.
Бошқа дори воситаларининг таъсири:
Ацетилсалицил кислота, индометацин, фенилбутазон пенициллинларнинг чиқарилишини камайтиради.
Бошка антибиотиклар ва кимётерапия воситалари:
Ампициллин/сульбактам препаратини бактериостатик кимётерапевтик воситалар ёки тетрациклинлар, эритромицин, сульфаниламидлар ёки хлорамфеникол каби антибиотиклар билан биргаликда қўллаш тавсия этилмайди, чунки бу даволаш самарадорлигини пасайтириши мумкин.
Аминогликозидлар:
Аминогликозидлар ампициллин билан *in vitro* шароитида фаолсизлантиради, шунинг учун уларни ампициллин/сульбактам билан битта инфузион эритмада аралаштириш мумкин эмас. Биргаликда қўллаш зарур бўлганда, препаратларни тананинг турли қисмларига камида бир соат оралигида юбориш керак.
Аллопуринол:
Аллопуринол билан даволанаётган подаграси бўлган пациентларда бир вактнинг ўзида ампициллин/сульбактамни қўллаш тери реакцияларининг ривожланиш хавфини оширади.
Антикоагулянтлар:
Пенициллинларни парентерал юборилганда кузатиладиган тромбоцитлар агрегацияси ва протромбин вактининг ўзгариши антикоагулянтлар билан бир вактда қўлланилганда кучайиши мумкин.
Метотрексат:
Метотрексат ва пенициллинларни бир вактда қўллаш метотрексат клиренсининг пасайишига ва натижада унинг токсиклигига олиб келади. Бундай пациентларни синчковлик билан кузатиш зарур, фолин кислотаси (лейковорин) дозасини ва давомийлигини ошириш имкониятини кўриб чикиш керак.
Пробенецид:
Пробенецид билан биргаликда қўлланилганда буйрак экскрециясини (тубуляр секрецияни) сусайтириш ҳисобига қон зардобида ампициллин ва сульбактам, шунингдек, ўтда ампициллин концентрациясининг ошиши ва узокроқ сакланишига олиб келади.
Гормонал контрацептивлар:
Аминопенициллинлар билан даволашда кам ҳолларда гормонал контрацептивлар (масалан, «ҳомиладорликка қарши таблеткалар») таъсирининг ишончлилиги пасайиши

мумкин. Шу муносабат билан контрацепциянинг ногормонал усулларини қўшимча равишда қўллаш тавсия этилади.

Лаборатория тестларига таъсири:
Сийдикда ампициллиннинг юкори концентрацияси глюкозурияни аниқлашда сохта мусбат натижаларга олиб келиши мумкин. Глюкозооксидаза билан ферментатив реакцияга асосланган глюкоза тестларидан фойдаланиш тавсия этилади.

Махсус кўрсатмалар
Ампициллин/сульбактам билан даволашни бошлашдан олдин пенициллинлар, цефалоспоринлар ёки бошка бета-лактам препаратларига нисбатан илгари ўтказилган юкори сезувчанлик реакциялари тўғрисида анамнезни синчковлик билан йиғиш керак.
Пенициллин билан даволанаётган пациентларда оғир ва баъзи ҳолларда ўлимга олиб келадиган юкори сезувчанлик реакциялари (анафилактоид типи) ривожланиши ҳақида хабар берилган. Бундай реакциялар кўпинча пенициллинлар, цефалоспоринлар, шунингдек, атопикларга нисбатан олдиндан юкори сезувчанлиги бўлган пациентларда пайдо бўлади.
Аллергик реакция пайдо бўлганда ампициллин/сульбактамни қўллашни дархол тўхтатиш ва тегишли мукобил даволашни тайинлаш керак.
Огир анафилактик реакциялар шошилинч адреналин билан даволашни талаб қилади. Зарур бўлса, кислород, глюкокортикостероидлар ҳам венага юборилади ва нафас йўлларининг ўтказувчанлигини таъминлайдиган тадбирлар, жумладан, интубация ўтказилади.
Пенициллинлар билан даволашни бошлашдан олдин пенициллинлар, цефалоспоринлар ва бошка препаратларга нисбатан илгари қайд этилган юкори сезувчанлик реакцияси мавжудлигини синчиклаб аниқлаш лозим.
Препаратни инфекцион мононуклеозга шубҳа қилинганда қўллашдан сақланиш керак, чунки бундай ҳолларда амоксициллинни қўллаш фонида кўпинча морбилга ўхшаш тошма ривожланади.
Узоқ муддат (14 кундан ортиқ) қўлланилганда, ҳаётий муҳим аъзолар, шу жумладан буйрак, жигар ва қон ишлаб чиқариш тизимининг функциясини даврий равишда баҳолаш тавсия этилади. Янги туғилган чақалоқлар ва бошқа педиатрик пациентларда мониторинг ўтказиш айниқса муҳимдир.
Ҳар қандай антибактериал давода бўлгани каби, шифокор сезгир бўлмаган микроорганизмларнинг (шу жумладан замбуруғларнинг) ортикча ўсиши белгиларига эътиборли бўлиши керак. Суперинфекция ривожланганда препаратни бекор қилиш ва зарур бўлса, тегишли даволашни буюриш керак.
Узоқ вакт қўлланилганда препаратга сезгир бўлмаган микроорганизмлар кўпайиб кетиши мумкин.
Ампициллин/сульбактам препарати билан даволаш даврида сийдикдаги глюкозани аниқлаш учун фақат глюкозооксидазали фермент усулларидан фойдаланиш керак, чунки ферментсиз усуллардан фойдаланганда сохта ижобий натижалар кузатилиши мумкин.
Жигар функцияси бузилишида қўллаш
Эҳтиётқорлик билан: жигар етишмовчилиги.
Буйрак функцияси бузилишида қўллаш
Эҳтиётқорлик билан: буйрак етишмовчилиги.
Болаларда қўллаш
Дозалаш тартибига кўра қўллаш мумкин.
Ҳомиладорлик ва лактация даврида қўлланилиши
Фертилик:
Ҳайвонларда ўтказилган клиник олди тадқиқотларда ампициллин ва сульбактам фертилликка салбий таъсир кўрсатмади.
Ҳомиладорлик:
Ампициллин ва сульбактамни ҳомиладор аёлларда қўллаш ҳақида чекланган маълумотлар мавжуд. Олинган маълумотлар ҳомиладорликнинг кечишига ёки ҳомила/янги туғилган чақалоқнинг соғлигига зарарли таъсир кўрсатмайди. Бироқ, биринчи уч ойлигида қўллаш бўйича маълумотлар етарли эмас. Ҳайвонларда ўтказилган тадқиқотларда тератоген таъсир белгилари аниқланмади.
Ампициллин/сульбактам препаратини ҳомиладорлик даврида фақат она учун кутилаётган фойда ҳомила учун потенциал хавфдан юкори бўлгандагина қўллаш мумкин.
Эмизиш даврида:
Ампициллин ва сульбактам кўкрак сути билан ажралади. Экскрециянинг паст даражасига қарамай, эмизикли болаларда диарея, шиллиқ қаватлар кандидози, шунингдек, аллергик сенсибилизация ривожланиши мумкин.
Агар эмизиш даврида препаратни буюриш зарур бўлса, бола ва она учун фойдасини ҳисобга олган ҳолда эмизишни тўхтатиш ёки давони бекор қилиш/тўхтатиш масаласини ҳал қилиш керак.
Автомобиль ва мураккаб механизмларни бошқариш қобилиятига таъсири
Ампициллин ва сульбактамнинг транспорт воситаларини бошқариш ва механизмлар билан ишлаш қобилиятига таъсирини ўрганиш бўйича махсус тадқиқотлар ўтказилмаган. Бирок, пациентларга препаратни қўллаш фонида реакция тезлиги ва диққатни жамлаш қобилиятини пасайтириши мумкин бўлган исталмаган реакциялар юзага келиши мумкинлиги ҳақида хабар бериш лозим.

Дозани ошириб юборилиши
Ампициллин/сульбактамнинг ўткир токсик таъсирини кузатиш тажрибаси чекланган. Дозани ошириб юбориш нохуш реакциялар профилига мос келадиган аломатларни келтириб чикариши мумкин, бунда кўрсатилган нажўя таъсирлар кўпрок кузатилиши ва якқолроқ намоён бўлиши мумкин.
β-лактам антибиотиклари жуда юкори дозаларда қўлланилганда тиришиш синдроми (тутқанок талвасалари) ривожланиши мумкин.
Ампициллин ва сульбактам гемодиализ ёрдамида организмдан чикарилиши сабабли, доза ошириб юборилганда, айниқса буйрак етишмовчилиги бўлган пациентларда, гемодиализ ўтказиш орқали элиминация самарадорлигини ошириш мумкин.
Даволаш:
Дозани ошириб юбориш натижасида келиб чиққан тиришишларда седатив давони диазепам ёрдамида қўллаш мумкин.

Чиқарилиш шакли
10 мл ҳажмли шишадан тайёрланган флаконлар, тиббиётда қўлланилишига доир йўриқномаси билан бирга картон кутиларга ўрамланган.
1 флакон препарати билан тиббиётда қўлланилишига доир йўриқномаси билан бирга картон ўрамларга жойланган.

Сақлаш шартлари
25°С дан юкори бўлмаган ҳароратда сақлансин.
Болалар ололмайдиган жойда сақлансин.

Яроқлилик муддати
3 йил.
Яроқлилик муддати утгач кулланилмасин
Дорихона таътили шартлари
Рецепт бўйича.

Ишлаб чиқарувчи
“SWISS PARENTERALS LTD,” Ҳиндистон.
Plot No. 402, 412-414, Kerala Industrial Estate,
G.I.D.C, Nr. Bavla, Ahmedabad-Gujarat, Ҳиндистон.
Веб сайти: http://swiss.in
E-mail: export@swiss.in

Ўзбекистон Республикаси ҳудудида дори воситасининг сифати бўйича шикоятлар (таклифлар) ни қабул қилувчи ташкилот номи ва манзили
“VENIT PHARM” МЧЖ
Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шахар, Учтепа тумани, 24-4-38;
Тел.: + 998907440043